

VERA LUCIA BARBOSA MOTA					
MEDICAMENTOS:	Bombinha (asma) / Pantanord / Colite				
SINTOMAS/QUEIXAS	HAS (Nega DM e colesterol).				
BANHEIRO	2X				
HORA QUE ACORDA	6hr sinta: 2hrs.				
HORA QUE DORME	22hr				
PRATICA EXERCICIO	não				
HORARIO DAS REFEIÇÕES					
CAFE: 8hr / Prule	ALMOÇO: 13.30	LANCHE: —	JANTA: —	café: 17hr	
- Auxiliar lavanderia. - Resp. nasal — Juc					
P = 5 - 15 cmH ₂ O					
13/06 P = 13 cmH ₂ O					
22 IAH = 2,0					
m. de uso: 6h45' Juc					
Bem adaptada					
11/07 P = 11.4 cmH ₂ O					
22 IAH.: 1,0					
m. de uso: 1h 25' Juc					
Bem adaptada					
21/11 P = 11.7 cmH ₂ O					
22 IAH = 1.7 / ev					
m. de uso: 1hr.					
Bem adaptada, s/ queixas — Juc.					
18/09 P = 11.7					
23 IAH = não estava utilizando — Juc					
23/10/23 P = 11.7 cmH ₂ O Auto 5 à 12.					
IAH = 0.9 e / ev					
m. de uso: 8 horas - Bem adaptada -					
fuga: 43l/min					
15/01 P = 10.5 cmH ₂ O					
24 IAH = 1.1 e / ev					
m. de uso: 1h 10'					
Bem adaptada, s/ queixas. — Juc					
01/04 P = 10.3 cmH ₂ O (mediana)					
24 IAH 0.8 e / ev					
m. de uso: 8h9'					
Bem adaptada Natacha					

Nome: VERA LUCIA BARBOSA MOTA

Peso: 88 kg

Data de Nascimento: 9-8-1971

Altura: 1,48 m

IMC: 40,18

Médico: DRA. GABRIELA DEL ROSARIO

Sexo: Feminino

MARQUEZ

Data do exame: 14-03-2022

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 14-03-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 537,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 48,0 e 212,0 minutos. O tempo total de sono foi de 404,0, eficiência de 75,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 64,0%; estágio N3: 15,8%; sono REM: 16,5%. O índice de despertares foi de 22,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 40,1/hora, sendo elas 151 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 119 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e mínima de 73%, permanecendo 65,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 68 - 85 bpm e NREM de 63 - 81 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco moderado durante o sono.

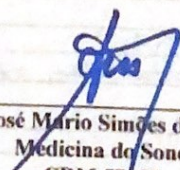
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 13,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

10/06/24	P = 5-12 cm H ₂ O	9,6 cm H ₂ O (mediana)
	IAH = 0,6 e/h	Mulherou - media de uso
	m de uso: 8h 39m	
	fuga: 20,4 l/m	
	Natasha	
30/09/2024	P: 8,4 cm H ₂ O	P ₁₅ : 10,6 cm H ₂ O
	IAH = 0,9 e/h	
	m de uso = 7h 40 min	→ mto escape
	fuga = 79 l/min	* hoco fixador * pico.
14/08	P = 10,5 cm H ₂ O	Bem adapt.
25	IAH = 0,9	
	m. de uso: 8h 20'	
	fuga = 11.	fuga